

Formato para crear Tesinas

1. Estructura de la Portada

La primera página debe contener los siguientes elementos en este orden:

- **Nombre de la Institución:** Institución principal y facultad (Ej. *Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología*).
- **Título del trabajo:** Centrado y en mayúsculas (Ej. *ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO...*).
- **Tipo de trabajo y propósito:** Se debe especificar qué es y para qué se presenta (Ej. *TESINA QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE [Tu carrera]*).
- **Autor:** Con la leyenda "PRESENTA:" seguida de tu nombre completo.
- **Asesores:** Nombre del Director y del Asesor del trabajo.
- **Lugar y fecha:** Ciudad y año de presentación (Ej. *México, D.F. 1998*).

2. Páginas Preliminares

- **Restricciones de Uso / Derechos de Autor:** Una página dedicada a especificar que el documento es para fines educativos e informativos, prohibiendo la reproducción total o parcial con fines de lucro y citando la Ley Federal del Derecho de Autor.
- **Agradecimientos:** Página(s) dedicada(s) a agradecer a las personas e instituciones que apoyaron el trabajo (Ej. A Dios, a los padres, a los hermanos, amigos y profesores/asesores).

3. Índice General

El índice debe estructurarse con el siguiente orden y niveles jerárquicos:

- Prólogo
- Introducción
- Antecedentes
- **Capítulos (Numeración decimal):**
 - Los capítulos principales llevan un solo número (Ej. *Capítulo 1*).
 - Los subtemas utilizan numeración decimal (Ej. *1.1, 1.2*).
 - Los sub-subtemas agregan otro decimal (Ej. *1.1.1, 1.1.2*).
 - Si se requieren listas dentro de los subtemas, se utilizan letras minúsculas con paréntesis de cierre (Ej. *a), b), c)*).
- Conclusiones
- Propuesta
- Bibliografía

4. Estructura del Cuerpo del Trabajo

- **Prólogo:** Explica el motivo de desarrollar la tesina, los objetivos que persigue y la necesidad a la que responde.
- **Introducción:** Profundiza en el tema, define conceptos clave y establece los propósitos del estudio.
- **Antecedentes:** Resumen histórico y evolución del tema de estudio, mencionando autores clave y fechas (orden cronológico).
- **Desarrollo (Capítulos):** Desarrollo exhaustivo de la investigación.
- **Conclusiones:** Resultados finales derivados de la investigación.
- **Propuesta:** Sugerencias, planes o tratamientos derivados de las conclusiones.
- **Bibliografía:** Lista final de referencias.

APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INVESTIGACION CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE LA SALUD

1. **COPILOT.** Asistente de escritura y análisis para redacción y programación científica.
2. **CHATGPT.** Modelo de lenguaje versátil para generar ideas, resúmenes y explicaciones complejas.
3. **CHATPDF.** Interacción directa con artículos científicos en PDF para extraer y comprender información clave.
4. **CONSENSUS.** Buscador de evidencia científica para encontrar respuestas validadas por estudios.
5. **GEMINI.** IA multimodal de Google para razonamiento avanzado, análisis de datos y búsqueda.
6. **PERPLEXITY.** Motor de búsqueda conversacional con citas precisas para investigación actualizada.
7. **DEEPL.** Traductor de alta precisión para documentos médicos y literatura en múltiples idiomas.
8. **CONNECTEDPAPERS:** Visualiza redes de citación para descubrir artículos relacionados.
9. **ELICIT:** Asistente de investigación que automatiza la revisión de literatura.
10. **SCISPACE:** Plataforma para entender artículos científicos con IA, chatear con PDFs y generar explicaciones.
11. **SEMANTICSCHOLAR:** Buscador académico inteligente que utiliza IA para entender el contexto de la búsqueda.

APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

1. **CHATGPT:** Modelo de lenguaje conversacional versátil para múltiples tareas.
2. **DEEPSEEK:** Potente en codificación, matemáticas y razonamiento avanzado.
3. **GEMINI:** IA multimodal de Google integrada en su ecosistema.
4. **PERPLEXITY:** Motor de búsqueda conversacional con citas y fuentes.
5. **COPILOT:** Asistente de IA integrado en Microsoft 365 para productividad.
6. **CLAUDE:** IA enfocada en seguridad, ética y procesamiento de documentos largos.
7. **GROK:** IA con acceso a información en tiempo real de X, conocida por su tono.

HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INVESTIGACIÓN

1. **CONSENSUS:** Busca y sintetiza respuestas científicas de papers.
2. **DEEPL:** Traductor preciso para documentos y textos académicos.
3. **RESEARCHRABBIT:** Descubre y mapea investigaciones relacionadas visualmente.
4. **NOTEBOOKLM:** Asistente de IA para organizar y entender tus fuentes.
5. **JASPER:** Generador de texto para acelerar la redacción académica.
6. **SCITE AI:** Analiza y verifica cómo se citan los artículos científicos.
7. **CONNECTED PAPERS:** Visualiza la red de papers y sus conexiones bibliográficas.

CARTEL DE INVESTIGACIÓN AMIC

- Los interesados deberán llenar la siguiente información:
 - Nombre completo del autor
 - Correo electrónico
 - Teléfono
 - Nombre de los coautores (incluido el asesor)
 - Institución a la que pertenece y donde se realizó el trabajo
- Solo puede participar en máximo 2 carteles como primer autor
- Podrá participar en otros resúmenes como coautor
- El autor principal deberá tener el consentimiento de todos los coautores que se registren en el resumen presentado
- Los autores no pueden dividir un estudio en varias presentaciones
- El contenido del resumen, deberá ser producto de una investigación original
- Los títulos múltiples (títulos en serie o numéricos) serán rechazados
- Seleccionar en la casilla el área de conocimiento en la que se desea participar y debe ser acorde al tema de investigación
- **El Resumen**, (máximo 300 palabras) debe contener la siguiente información:
 - Título (no mayor a 12 palabras y de preferencia escrito con letras mayúsculas)
 - Objetivo
 - Introducción o antecedentes
 - Metodología
 - Resultados
 - Conclusiones
- **Si desea presentar casos clínicos**, el resumen deberá contener:
 - Título
 - Introducción o antecedentes
 - Objetivo
 - Presentación del caso con diagnóstico y tratamiento
 - Resultados del tratamiento y/o conclusiones

Registro de participantes

- Los carteles serán presentados únicamente por los estudiantes y no deberá presentar más de 2 carteles como autor
- Para que los resúmenes sean registrados, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la página del congreso
- Las memorias se publicarán un mes después del evento
- La colocación de carteles será el **9 de mayo**
- Colocación: 08:00 - 10:00 h
- Exposición: 10:00 - 13:00 h
- Retiro del cartel: 13:00 h

Para cualquier información relacionada con el evento, consultar la página www.odonto.unam.mx o dirigirse al siguiente correo: amicunam@fo.odonto.unam.mx

FORMATO DEL CARTEL DE AMIC

- El cartel deberá medir 90 cm. de ancho por 1.20 m de alto
- El título deberá colocarse en la parte superior y al centro del cartel. Las letras del título deberán ser de 2.5cm de altura aproximadamente
- Debajo del título, colocar el nombre de la institución que representa y donde se realizó el trabajo
- Inmediatamente después, colocar los nombres del autor principal y presentador con un asterisco y los nombres de los colaboradores
- Las letras del texto y las de los pies de figuras y tablas deberán ser de 1 cm de altura para que puedan ser leídas a 2 metros de distancia
- El cartel deberá versar exclusivamente sobre el contenido del resumen
- La secuencia del cartel deberá estar indicada para facilitarle al espectador su lectura
- El costo por montaje y uso de mamparas es de \$400.00 por cartel, este costo deberá cubrirse del 6 al 8 de **mayo** en el área de registro del congreso, frente a los salones Olmecas del World Trade Center, CDMX.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

1.Registro. Puedes acceder al registro escaneando el código QR de alguno de los carteles o buscando directamente en la página de la Facultad de Odontología de la UNAM

2. Ingreso del resumen Puedes ingresar y modificar datos personales, tu resumen o imprimir tu comprobante. Recuerda que tu resumen debe constar máximo de 300 palabras (divididas en los campos que ahí se presentan).

3. Comprobante Aquí podrás imprimir el comprobante de registro de tu resumen. Es importante que llenes todos los campos ya que así lo entregarás el día del congreso.

Tu información será enviada a nuestra base de datos y ya no podrás hacer cambios.

4. Imprime tu comprobante Imprime tu comprobante, el cual contiene tu número de registro y luego da click en el botón terminar.

5.- Termina tu registro

Orden Cronológico para realizar un cartel científico para investigación

Paso 1: Revisar los lineamientos del congreso. Antes de diseñar, debes conocer las exigencias del evento. La dimensión estándar suele ser el formato A0 (118.9 x 84.1 cm) Verifica si la orientación exigida es vertical (retrato) u horizontal (apaisado). Ignorar esto resultará en un cartel recortado o mal ajustado en los paneles del evento

Paso 2: Sintetizar la información y estructurarla. Aplica la regla del 50/50: 50% de información textual y 50% de elementos visuales (gráficas, figuras, tablas) Utiliza la regla del 6x6, procurando que tus párrafos no excedan las 6 líneas y cada sección tenga un máximo de 250 palabras

La **estructura obligatoria** debe contener:

Título: Corto y llamativo (no más de 4-5 palabras centrales si es posible).

Autores y Adscripción: Tu nombre, afiliación (logos institucionales) y correo. Deben ir en un tamaño menor al título .

Introducción: Pregunta de investigación y objetivos.

Metodología: Especialmente importante para justificar la recolección de tus datos de salud.

Resultados: Es el corazón del cartel. Debe ser altamente visual.

Conclusiones: Qué aporta la investigación a la práctica clínica o científica.

Referencias y Agradecimientos: Breves e impresos en un tamaño pequeño.

Paso 3: Elección de herramientas, diseño y colorimetría Selecciona la herramienta digital, define tu paleta de colores y elige la tipografía (detalles más abajo). Apóyate en plantillas prediseñadas para ahorrar horas de alineación y estructuración.

Paso 4: Inserción de gráficos e imágenes (Consideraciones Éticas en Salud). Es vital el rigor en esta etapa. En el área médica, debes tener el consentimiento informado por escrito de los pacientes para utilizar fotografías clínicas, especialmente si muestran el rostro o patologías específicas. Asegúrate de que todas las imágenes o gráficos tengan una resolución de al menos 300 ppi (puntos por pulgada) para evitar que se pixelen al imprimir. Evita fotos distorsionadas o de repositorios con marcas de agua. Si presentas datos no publicados, puedes agregar un ícono indicando que está prohibido que los asistentes tomen fotografías.

Paso 5: Exportación, revisión exhaustiva e impresión Exporta el documento siempre en formato PDF estándar para impresión. Revisa el archivo final haciendo zoom para detectar errores tipográficos o textos solapados.

Tips de Diseño, Tipografía y Colorimetría para un cartel científico de investigación

Tipografía y Tamaños: No sobrecargues el póster usando letras minúsculas. Los tamaños recomendados para una lectura cómoda a 1-1.5 metros de distancia son:

Título principal: 32 puntos o más

Subtítulos (secciones): 24 a 28 puntos

Texto general (cuerpo): 18 a 20 puntos

Referencias/Notas al pie: 12 a 14 puntos Para la lectura en bloques de texto, algunas convenciones de diseño sugieren fuentes Serif (con patines, como Times New Roman) para facilitar la lectura , mientras que para los títulos, fuentes Sans-serif (sin patines, como Arial) aportan limpieza y visibilidad Evita usar más de dos fuentes distintas para mantener la uniformidad

Colorimetría: Apunta a la "pregnancia" (impacto visual claro y recordable) . Elige tres tonos basándote en el círculo cromático . Puedes generar alto contraste combinando opuestos (ej. azules/turquesas con naranjas) y utilizar un tercer color neutro (como un gris claro o tono crema) para mediar y equilibrar la composición. No satures de colores estridentes, o harás que la lectura sea molesta

Logos: Trata los logos de las universidades o clínicas con cuidado; no los deformes y asegúrate de que estén en alta calidad, pues de lo contrario demeritan el aspecto profesional

Herramientas y Librerías Recomendadas para realizar un cartel de exposición o un caso clínico.

BioRender: Es la mejor herramienta absoluta para el área de la salud/biomédica. Contiene iconos científicos pre-vectorizados de altísima calidad (órganos, ADN, equipos médicos, virus) . Además, incluye plantillas exactas para pósters científicos con los espacios ya distribuidos para títulos, logos y gráficos

Canva / PictoChart: Alternativas muy accesibles y gratuitas que ofrecen plantillas (templates) para posters y elementos gráficos fáciles de modificar

PowerPoint: Sumamente confiable si ajustas el tamaño de la diapositiva en centímetros (ej. 118.9 x 84.1 cm) desde el inicio . Es compatible con todo, aunque requiere más habilidad para alinear los cuadros de texto.

DaFont: Un banco de tipografías gratuitas útil si quieres destacar el título principal con letras más modernas

Trucos y Atajos (Ahorro de Tiempo y Mejora de Calidad)

Gráficos con anotaciones centrales: No exportes una gráfica estadística de Excel o SPSS y la pegues sin más. Añádele recuadros o flechas anotadas destacando la conclusión o hallazgo principal en esa misma imagen. Así el lector comprenderá tus resultados en segundos sin tener que leer toda la metodología

Cuidado con el papel de impresión: No uses papel Bond de bajo gramaje, ya que la tinta humedece el papel, provocando que se arrugue y se vea muy descuidado al colgarlo Por otro lado, un papel fotográfico extremadamente brillante (como propalcote grueso) puede reflejar las luces del salón y dificultar la lectura Solicita un papel de gramaje intermedio (150 a 170 gramos) con acabado mate

Guía de Citación Vancouver

1. En el Texto (La Cita)

No uses nombres ni fechas, solo números. Estos números deben seguir el orden en que aparecen por primera vez.

- Una sola fuente: "El lavado de manos reduce el riesgo de infección (1)."
- Varias fuentes: "Diversos estudios confirman esta teoría (1, 3, 5-8)."
- Autor mencionado: "Según García (2), el tratamiento es efectivo."

En la Bibliografía (La Referencia)

La lista al final del documento se numera según el orden de aparición.

Artículo

- Formato: Autor. Título. Revista. Año;Vol(Nº):Págs.
- Ejemplo: Pérez A. Cirugía robótica. Rev Med. 2024;12(2):45-50.

Libro

- Formato: Autor. Título. Edición. Ciudad: Editorial; Año.
- Ejemplo: Gómez L. Anatomía Humana. 3ª ed. Madrid: Ed. Médica; 2023.

Sitio Web

- Formato: Autor/Org. Título [Internet]. Año [citado fecha]. URL
- Ejemplo: OMS. Guía COVID-19 [Internet]. 2025 [citado 10 mar 2026]. Disponible en: <http://oms.int/guia>

Imágenes:

En el texto, se coloca un número entre paréntesis o como superíndice (ejemplo: Figura 1 (1)) y, justo debajo de la imagen, se añade una leyenda con la etiqueta y una breve descripción. Finalmente, en la sección de bibliografía, se detalla la fuente completa según su origen (sitio web, libro o revista), asegurando que el número coincida con el de la figura.

De un sitio web:

- Formato: Autor/Organización. Título de la imagen [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Año [citado el día mes año]. Disponible en: URL
- Ejemplo: Organización Mundial de la Salud. Estructura del diente [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [citado el 23 de marzo de 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/salud-dental/imagen>

De un libro impreso:

- **Formato: Autor del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; Año. Figura [número], Título de la imagen; p. [página].**
- Ejemplo: Netter FH. Atlas de anatomía humana. 7a ed. Barcelona: Elsevier; 2019. Figura 4, Músculos de la masticación; p. 55.

Imagen de artículo de revista

- **Formato: Autor(es). Título del artículo. Nombre de la revista [Internet]. Año [citado el día mes año]; volumen (número): [páginas]. Figura [número], Título de la imagen; p. [página]. Disponible en: URL**

Si es de autoría propia:

- En la leyenda debajo de la imagen simplemente colocas: Figura 1. Radiografía periapical de primer molar superior. Fuente: Elaboración propia. (En este caso, no se incluye en la lista de referencias final).

Opciones en línea para realizarlas

- Zotero
- Mendeley
- MyBib

Requisitos de presentación de cartel para el congreso nacional e internacional de posgrado de investigación de odontología 2026 / Cartel de cancún

- En esta modalidad se aceptarán casos clínicos y/o investigaciones y/o revisiones de literatura
- El contenido del cartel debe corresponder al contenido del resumen aceptado.
- El cartel deberá medir 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
- Deberá usar la plantilla proporcionada a continuación para la elaboración de su cartel.
- Presentación Cartel Power Point
- En el cartel se debe colocar el escudo de su universidad y/o facultad o escuela correspondiente, con un tamaño sugerido de 10×10 cm.
- Colocar el nombre de la institución que representa, al centro del cartel.
- El título del trabajo deberá colocarse por debajo de la institución.
- Las letras del título deberán ser de 90 puntos de altura aproximadamente.
- Colocar los nombres del autor principal (*con asterisco) y los nombres de los coautores.
- Debajo de los nombres de los autores deben estar las adscripciones de cada autor y ser indicados con superíndices.
- Las letras del texto deben ser aproximadamente de 45 puntos y la de los pies de figura o tablas deben ser de 30 puntos (tamaño sugerido).
- La secuencia del cartel deberá estar indicada para facilitar su lectura.
- Todos los carteles serán evaluados por un comité revisor.
- La constancia de participación académica se enviará electrónicamente.

1. El Marco Estructural CARE: Los 13 Ítems Esenciales

La transparencia y la completitud son los pilares de la utilidad científica. Siguiendo la misión de la red **EQUATOR**, las guías CARE (2013/2017) establecen un marco de consenso obligatorio para evitar omisiones críticas. Un componente revolucionario es la **Perspectiva del Paciente**, que integra su "voz y experiencia" como un desenlace clínico válido en la medicina moderna basada en la evidencia. Asimismo, la **Línea de Tiempo (Timeline)** ha dejado de ser una simple secuencia para convertirse en una herramienta metodológica que mitiga el "sesgo de memoria" (recall bias).

Para optimizar la producción, los autores deben utilizar **CARE-writer**, recurso diseñado para alinear el manuscrito con estos estándares internacionales de forma automatizada.

Sección	Ítem	Descripción Requerida
Título	1	Impactante y novedoso. Debe incluir "reporte de caso" y el fenómeno de interés.
Palabras Clave	2	2 a 5 términos que faciliten la indexación (preferiblemente MeSH).
Resumen	3	Estructurado (150-200 palabras): Introducción, hallazgos, diagnóstico e intervenciones.
Introducción	4	Antecedentes y justificación del caso basada en literatura relevante.
Información del Paciente	5	Datos demográficos, historia médica, familiar y estilo de vida relevante.
Hallazgos Clínicos	6	Descripción precisa de síntomas y hallazgos del examen físico.
Línea de Tiempo	7	Representación visual (tabla/figura) de hitos, fechas y tiempos de evolución.
Evaluación Diagnóstica	8	Métodos, razonamiento, diagnósticos diferenciales y pronóstico.
Intervenciones	9	Tipos de intervención (dosis, duración) y justificación de cambios de plan.

Seguimiento	10	Curso clínico, adherencia, tolerancia y eventos adversos (morbimortalidad).
Discusión	11	Fortalezas, limitaciones, comparación con la literatura y lecciones aprendidas.
Perspectiva del Paciente	12	Relato directo de la experiencia del paciente sobre el tratamiento.
Consentimiento	13	Declaración obligatoria de obtención del consentimiento informado firmado.

Este marco evoluciona drásticamente cuando la intervención es quirúrgica o radiológica, exigiendo un nivel de detalle técnico que triplica el esfuerzo documental pero garantiza la seguridad del paciente.

2. Especialización y Evolución: El Rigor Prospectivo en Cirugía y Radiología

La tendencia actual hacia el "rigor prospectivo" exige que las extensiones de las guías CARE respondan a la variabilidad técnica de cada disciplina. Como Editor, advierto: cumplir estas guías triplica la carga de trabajo de autores y revisores, pero es el precio necesario para la integridad científica.

- **SCARE 2023 (Cirugía):** Con 36 ítems, es **obligatorio** detallar la técnica quirúrgica paso a paso, la curva de aprendizaje del cirujano y el uso de **observadores independientes** para validar la descripción técnica. Es mandatorio categorizar las complicaciones mediante la **Clasificación de Clavien-Dindo**, incluyendo específicamente la **morbimortalidad a los 30 días**.
- **CARE-Radiology 2024 (Imagenología):** Con 38 ítems, exige la máxima reproducibilidad tecnológica. Se debe reportar el software de post-procesamiento y los ajustes (settings) del equipo. Es un requisito de calidad declarar la **profesión y años de experiencia del especialista** que interpreta la imagen. Además, es obligatoria la **divulgación detallada del uso de Inteligencia Artificial (IA)**, especificando la herramienta o software exacto empleado.

La validez de estas intervenciones depende estrictamente de la calidad de la evidencia visual recolectada, lo que nos obliga a dominar la técnica fotográfica.

3. Fundamentos de la Fotografía Clínica: Equipamiento y Requisitos

La fotografía clínica es una prueba legal y una herramienta diagnóstica; su calidad determina la reproducibilidad del caso. No se aceptan registros improvisados.

Comparativa de Equipamiento Técnico:

Característica	Cámara Compacta / Smartphone	Cámara Réflex (DSLR)
Pros	Bajo costo, fácil transporte (6.1 - 12 Megapíxeles).	Sin distorsión, control manual total, sensor superior.

Contras	Insuficiencia de flash , distorsión, macro limitado.	Alto costo, peso elevado, requiere capacitación técnica.
----------------	---	--

Componentes Críticos para la Excelencia:

- **Lentes:** En odontología y clínica, es mandatorio el uso de objetivos **Macro (60-105 mm)**.
- **Iluminación:** Sistemas de **Flash O-Ring (circular) o Twin Flash** para eliminar sombras en cavidades.
- **Programación Manual Sugerida:**
 - **ISO:** 400-800 para extraoral (para compensar luz sin perder profundidad); ISO 200 para intraoral.
 - **Velocidad:** 1/125.
 - **Apertura:** F11 (extraoral) hasta F25 o más (intraoral) para máxima profundidad de campo.

4. Protocolo de Captura: Fotografía Extraoral e Intraoral

El enfoque debe ser puramente clínico. Se exige la eliminación de cualquier distractor (pelo, joyas, piercings) y el uso de fondos uniformes (blanco, gris o azul mate).

- **Protocolo Extraoral:** Rostro en reposo y sonrisa, perfiles y cuerpo completo (frente/espalda/lateral). En el rostro, el plano bipupilar debe estar paralelo al piso.
- **Protocolo Intraoral:** Es obligatorio el uso de **espejos con rodio y tratamiento antiempañante**, además de retractores de mejilla adecuados. La lente debe estar estrictamente **perpendicular al plano oclusal**; esto es crítico para evitar **escorzar (elongar o acortar)** las imágenes, lo que invalidaría el análisis métrico del caso.
- **Tomas en MIC:** Frontal (centrada en incisivos), laterales (centradas en caninos) y oclusales (superior e inferior mediante espejos).

5. Ética Documental: Consentimiento e Identidad

El consentimiento informado es el "seguro de vida" del investigador. Como norma de excelencia, este debe obtenerse **tan pronto como se considere que el caso es publicable**, delimitando claramente su uso en docencia, publicación o redes científicas.

Anonimización Crítica:

- **Prohibición absoluta:** Nombres, iniciales, números de historia clínica o fechas exactas en imágenes y texto.
- **Rasgos Identificables:** En imágenes intraorales o radiológicas, se deben eliminar todos los identificadores. En rostros, se deben enmascarar los ojos a menos que sean el objeto del caso, garantizando siempre la máxima protección de la identidad según normativas éticas.

6. Redacción Final, Citación y Bibliografía

La redacción es un ejercicio de síntesis rigurosa. En las revistas de alto impacto, "menos es más":

- **Límites de extensión:** Máximo **1,000 palabras** (límite estricto para la mayoría de revistas especializadas). El resumen debe tener exactamente **150-200 palabras**.
- **Referencias:** Mínimo **20 citas** actualizadas (últimos 5 años), siguiendo el estilo **Vancouver**. Es recomendable citar trabajos previos de la revista donde se postula para demostrar conocimiento del foro.
- **Checklist Final:** Antes del envío, declare formalmente los conflictos de interés, fuentes de financiación y asegure que el título sea **impactante y novedoso**.

7. Conclusiones y Mejores Prácticas

El reporte de caso ha evolucionado de la narrativa anecdótica a una herramienta de datos técnicos de alta utilidad científica. Adoptar las guías CARE, SCARE o CARE-Radiology no es una carga burocrática, sino una **garantía de rigor y profesionalismo** que eleva la calidad de la evidencia global.

La integridad de la investigación clínica exige una actualización permanente en estas metodologías. Insto a cada clínico a documentar sus hallazgos con la convicción de que **"todo médico tiene un caso digno de publicar"**, siempre que esté dispuesto a hacerlo bajo los estándares de la excelencia documental.

Directorio de Publicación de Casos Clínicos en Odontología

Revistas Científicas Odontológicas

1. Revista ADM (Asociación Dental Mexicana)

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Casos clínicos de especial interés y aplicación práctica para el odontólogo de práctica general

Abarcan todas las especialidades (cirugía, periodoncia, endodoncia, ortodoncia, etc.)

Requisitos estrictos de formato:

- Límite de extensión: Máximo 8 páginas, incluyendo la bibliografía (sin contar página inicial, resumen ni declaración de conflictos)
- Límite de imágenes y tablas: No más de 8 fotografías (en formato JPG, calidad digital profesional) y un máximo de 2 tablas
- Resumen: Debe tener entre 150 y 300 palabras, estructurado y traducido al inglés (abstract)
- Estilo de citación: Estilo Vancouver (adaptado al Index Medicus), referenciadas con números arábigos en superíndice de manera consecutiva

Criterios de rechazo comunes:

- Falta de originalidad del manuscrito
- Ausencia del consentimiento informado del paciente o vulneración de su privacidad
- Incurrir en faltas éticas como plagio, fragmentación de datos (publicación "salami") o conflictos de interés no declarados
- El incumplimiento estricto de las normas para autores provoca retrasos o el rechazo directo del manuscrito

2. Revista Cubana de Estomatología (RCE)

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Casos de estomatología general y sus especialidades

Poseen una sección fija exclusiva denominada "Presentación de casos"

Suelen publicar casos sobre patologías raras, técnicas quirúrgicas (ej. distracción osteogénica) o anomalías del desarrollo

Requisitos estrictos de formato:

- El texto debe seguir la estructura tradicional del caso clínico: introducción, presentación del caso y discusión/conclusiones
- Requieren resúmenes estructurados y palabras clave indexadas (DeCS/MeSH)
- Criterios de rechazo comunes: Publicación duplicada o redundante, donde los autores envían el mismo caso a diferentes revistas
- Diseños de casos sin una justificación clara de su rareza o aporte educativo

3. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (MOPOyCB)

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Casos enfocados en los aspectos clínico-patológicos, médico-terapéuticos y/o quirúrgicos de enfermedades que tengan repercusión en la cavidad oral

Requisitos estrictos de formato:

- Títulos concisos que identifiquen claramente que se trata de un reporte de caso
- Estructura narrativa cronológica para la descripción del caso y la revisión selectiva de literatura

Criterios de rechazo comunes:

- Falta de rigor diagnóstico. Si el diagnóstico definitivo no está sustentado con evidencias sólidas (como estudios histopatológicos o tomográficos cuando aplique), el caso carece de validez científica

4. Revista del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España (RCOE)

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Odonto-estomatología teórica y práctica

Se interesan en casos que describan desde procedimientos quirúrgicos hasta manejo de traumatismos dentales y anomalías de unión dental

Requisitos estrictos de formato:

- Inclusión explícita del apartado "Casos Clínicos" o "Artículos clínicos" en el formato
- Referencias en sistema Vancouver acotadas a la discusión y justificación del caso

Criterios de rechazo comunes:

- Evaluaciones incompletas del paciente o fallas en contrastar los resultados obtenidos en el caso con la literatura médica/odontológica relevante

5. Revista Odontología Sanmarquina

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Casos clínicos odontológicos en general, valorando su utilidad como material formativo y clínico

Requisitos estrictos de formato:

- Exigen resumen y palabras clave en dos idiomas (español e inglés)
- Aplicación estricta de las normas del estilo Vancouver para las referencias bibliográficas

Criterios de rechazo comunes:

- Omisión del consentimiento informado del paciente (identificado como una falla mayor en revisiones de la revista)
- No citar la bibliografía correctamente en el texto

Congresos y Eventos Científicos

1. Celebración Nacional Estudiantil ADM / Congresos ADM

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Casos de interés general enfocados en la educación continua para odontólogos y estudiantes de pregrado y posgrado

Requisitos estrictos de formato:

- Formato de presentación mediante Concurso Nacional de Carteles o póster científico
- Requieren esquematizar visualmente el caso con iconografía de alta calidad (pre, trans y postoperatoria)

Criterios de rechazo comunes:

- Fotografías que permitan la identificación del paciente sin anonimización o permiso previo (violación a la privacidad)
- Extensión de texto desmesurada que rompe el formato visual del póster

2. Congresos Científicos Internacionales (ej. FELSOCCEM / Jornadas Universitarias)

Enfoque o tipo de casos que aceptan: Casos que reporten una enfermedad rara, asociaciones inesperadas de patologías o un enfoque práctico novedoso liderado por estudiantes, residentes o especialistas en formación

.Requisitos estrictos de formato:

- Resumen de sometimiento que deje absolutamente claro el mensaje educativo ("take-away lesson") y justifique la originalidad

Criterios de rechazo comunes:

- Casos puramente anecdóticos que no aporten nuevo conocimiento clínico ni tengan valor pedagógico ("publicar por publicar")
- Mala calidad metodológica en la revisión bibliográfica

.

1. Estructura Obligatoria del Manuscrito

El manuscrito debe seguir una estructura estandarizada, lógica y jerárquica, fuertemente respaldada por lineamientos internacionales como la Declaración CARE

- **Introducción:** Debe captar el interés del lector de forma breve y sintética. Incluye una justificación clara de por qué el caso es único, novedoso o raro. Es indispensable presentar un breve resumen de los antecedentes del caso, una revisión selectiva de la literatura médica pertinente para dar contexto y, finalmente, indicar con precisión el objetivo de la publicación
- **Presentación del Caso (o Caso Clínico):** Es el relato detallado y estrictamente redactado en orden cronológico. En esta sección se documenta exhaustivamente la historia clínica, los resultados de los exámenes (físicos, de laboratorio y radiográficos), el diagnóstico definitivo, las intervenciones terapéuticas realizadas y la evolución o seguimiento clínico del paciente
- **Discusión:** Representa el núcleo analítico del manuscrito. Aquí se deben evaluar y sustentar los hallazgos principales, contrastándolos rigurosamente con la literatura científica existente. Además, se deben analizar las fortalezas y limitaciones del abordaje del caso.
- **Conclusión:** Debe ser una síntesis cauta y concisa. Resalta las principales lecciones que se pueden extraer ("take-away lessons") y su aplicación directa a la práctica clínica, evitando generalizaciones universales basadas en un solo caso.

2. Información Médica Esencial en Anamnesis y Examen Físico

El reporte debe ser un balance perfecto entre la exhaustividad técnica y la concisión, desechando elementos superfluos que no aporten al razonamiento clínico.

En la Anamnesis (Historia Clínica):

- **Datos demográficos del paciente:** Es fundamental incluir información como edad, sexo, origen étnico, profesión/ocupación y lugar de residencia, siempre que sean médicamente relevantes
- **Síntoma primario o pivote:** Descripción exacta de las principales quejas o motivo de consulta del paciente
- **Antecedentes estructurados:** Historial médico, familiar y psicosocial, lo cual incluye estilo de vida, dieta e información genética pertinente
- **Comorbilidades e intervenciones previas:** Registro de enfermedades concomitantes y detalles exactos de intervenciones médicas o quirúrgicas anteriores junto con sus resultados

En el Examen Físico:

- **Signos vitales:** Deben documentarse al inicio de la exploración física como línea base
- **Hallazgos positivos y negativos pertinentes:** Se deben reportar de manera minuciosa, organizados por órganos y sistemas, destacando únicamente aquello que influya en el diagnóstico diferencial o en el plan de tratamiento

3. Redacción de una Discusión con Peso Científico

Para que la sección de 'Discusión' trascienda un simple resumen narrativo y posea verdadero peso científico, debe estructurarse analíticamente:

- **Inferencias y deducciones:** El autor debe plasmar su razonamiento clínico avanzado, explicando las deducciones extraídas de los hallazgos en lugar de limitarse a repetir mecánicamente lo ocurrido
- **Confrontación sistemática con la literatura:** Los resultados, diagnósticos y decisiones terapéuticas deben discutirse a la luz de los artículos publicados; se debe debatir si el caso en cuestión confirma, difiere o cuestiona lo reportado por otros autores

- Evaluación de limitaciones: Exige un alto nivel de honestidad intelectual. El autor debe ser crítico con su propio caso, señalando claramente las limitaciones metodológicas o clínicas que se presentaron (por ejemplo, imposibilidad de realizar ciertas pruebas), y describir el significado e impacto de estas limitaciones en el resultado
- Generación de hipótesis: Un caso de excelencia aprovecha su singularidad para sugerir a los lectores nuevas hipótesis, teorías o líneas de investigación (como posibles mecanismos fisiopatológicos o patogénicos) que deberán ser probadas en futuros ensayos clínicos

4. Consideraciones Éticas y Anonimización del Paciente

La ética es el pilar innegociable de toda publicación científica

El incumplimiento de estos parámetros resulta en el rechazo inmediato del manuscrito.

- Consentimiento Informado: Es estrictamente obligatorio obtener el consentimiento informado por escrito del paciente (o de su representante legal en caso de menores o personas con facultades limitadas) para la publicación de sus datos y, de manera muy especial, de sus imágenes
- Desidentificación total: Se deben omitir o enmascarar rigurosamente los nombres, iniciales, fechas exactas identificables y, sobre todo, el número de la historia clínica o expediente del enfermo
- Privacidad en el material gráfico: La identidad en fotografías e imágenes diagnósticas debe estar absolutamente resguardada. Como regla de oro en edición médica: las barras que cubren únicamente los ojos de los pacientes no son suficientes para proteger su identidad
- Si se muestran partes del cuerpo, no deben incluirse rasgos accesorios que permitan identificar al individuo, como marcas de nacimiento o tatuajes, salvo que sean el objeto clínico central del estudio y cuenten con permiso explícito

Presentación Visual y Oral del Caso Clínico

1. Estructura de Diapositivas y Carteles (Pósteres)

Aunque el diseño gráfico queda a criterio del autor, la literatura científica dicta normas claras sobre la distribución y cantidad de información:

Regla de la densidad gráfica: Un caso clínico escrito debe ser muy visual, pero las fuentes dictan que debe ser "menos que un póster científico, pero más que un artículo". Esto implica que en un formato de cartel o presentación, la imagen debe dominar absolutamente sobre el texto.

- **Títulos concisos:** Los títulos en pósteres y presentaciones tienden a ser directos. Estudios demuestran que la extensión promedio de un título para carteles es de 12 palabras
- **Supresión de la revisión bibliográfica:** A diferencia del manuscrito, en la modalidad oral (ya sea en congresos, ateneos o pases de visita) no se incluye una revisión extensa de la literatura. El contenido debe ir directo a los hallazgos clínicos del paciente y su evolución
- **Tiempo de exposición:** La defensa oral de un cartel en un congreso se realiza de forma muy ejecutiva, habitualmente en menos de 10 minutos

2. Reglas de Oro para la Iconografía y Fotografía Clínica

La fotografía clínica es quizás el elemento más examinado por los comités editoriales y jurados.

- **Volumen de imágenes:** Las directrices editoriales limitan la cantidad de imágenes. Generalmente se acepta un rango de 2 a 5 fotografías para ilustrar elementos clave, o un máximo de 6 a 8 imágenes dependiendo de la revista. En promedio, los casos publicados utilizan 6.25 imágenes
- **Secuencia obligatoria:** Todo caso debe contar con una documentación clínica e iconográfica completa que abarque el preoperatorio, postoperatorio y el seguimiento.
- **Calidad y formato:** Las fotografías deben realizarse de manera profesional, poseer calidad digital y entregarse en formato JPG.
- **Señalización dirigida:** Las imágenes (como radiografías) no lo explican todo por sí solas. Si muestran hallazgos que no son identificables a simple vista para un lector no experto, deben señalarse obligatoriamente con flechas o asteriscos

Anonimización estricta (Regla Crítica):

Es un estándar absoluto que las barras negras que cubren únicamente los ojos NO son suficientes para resguardar la identidad del paciente.

- La anonimización de imágenes frontales del rostro debe cubrir los ojos y las cejas simultáneamente.
- En las fotografías de partes del cuerpo, se debe excluir cualquier rasgo único que facilite la identificación, como marcas de nacimiento o tatuajes.
- No debe existir ningún dato en radiografías o ecografías que permita identificar al paciente (nombres, número de historia clínica)
- **Pies de foto:** Deben ser textos escuetos, autoexplicativos, y aclarar qué indican las flechas o asteriscos. Además, se aconseja anotar el nombre del caso clínico en las fotos para mantener el orden.
-

3. Consejos de Oratoria y Defensa del Caso

El objetivo de la defensa oral (congresos, jornadas, ateneos) es el intercambio activo de ideas

- **Dinámica de la defensa en pósteres:** El autor debe permanecer de pie junto a su trabajo en el horario asignado, con la disposición de interactuar con evaluadores o colegas. El objetivo no es leer el póster, sino estar preparado para responder preguntas y generar un intercambio de experiencias valioso

- Enfoque narrativo sencillo: Durante la presentación oral, la historia clínica, los procedimientos diagnósticos y la evolución deben narrarse en un lenguaje sencillo, coherente y ameno, captando la atención de la audiencia clínica. Se debe evitar tratar de impresionar a la audiencia con largas disquisiciones o listas bibliográficas interminables
- Resaltar el mensaje educativo: El discurso debe culminar con lecciones claras ("take-away lessons"). La oratoria debe convencer a la audiencia de por qué el caso es relevante y qué pueden llevarse a su propia práctica clínica

4. Errores Visuales que Restan Profesionalismo

Como revisores, frecuentemente penalizamos presentaciones y manuscritos por los siguientes errores visuales y de formato:

- Redundancia texto-imagen: Es un error grave repetir en el cuerpo del texto la información exacta que ya está detallada en una tabla o figura. Las tablas e imágenes deben explicarse por sí mismas
- Saturación de datos irrelevantes: Incluir tablas interminables con resultados de laboratorio que no son pertinentes al caso. Solo deben tabularse los datos verdaderamente relevantes.
- Fracaso en la protección de la privacidad: Mostrar el número de expediente del hospital, iniciales del paciente o fechas exactas en los márgenes de las radiografías o tomografías
- Imágenes sin guía visual: Presentar cortes tomográficos o histopatológicos complejos asumiendo que la audiencia verá la patología de inmediato, sin haber insertado señalética (flechas) gráfica
- Desorden cronológico: Presentar esquemas visuales, tablas o la narrativa oral saltando en el tiempo. El desorden cronológico dificulta la comprensión y construye un relato falso de lo ocurrido; se sugiere utilizar una línea de tiempo (cronograma) cuando hay sucesivas pruebas o intervenciones